

Procedimento Operacional Padrão – POP				
Publicação	Numeração	Versão	Páginas	Anexos
13/10/2025	SES.DGE/DAP/DT nº 48	nº 06	16	03
Nome do Procedimento: Como Realizar Testes Rápidos (TRs) para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs)				
Gerência(s) Responsável(eis) pelo(s) Serviço(s) Executante(s): Gerências da Atenção Primária, Gerência de Serviços Especiais, Gerência de Urgência e Emergência e Articulação Hospitalar, Gerência de Assistência Farmacêutica e Laboratório, Gerência Técnica de Odontologia, Gerência de Vigilância em Saúde.				
Serviço(s) Responsável(eis) Pela Execução do POP: Todas as Unidades de Saúde e outros serviços de saúde.				
Cargo(s) Responsável(eis) Pela Execução das Tarefas: Enfermeiros, Farmacêuticos, Médicos, Odontólogos e Técnicos de Enfermagem sob supervisão do Enfermeiro, com curso e certificação pela Plataforma TeleLab do Ministério da Saúde				
Objetivo(s): Orientar quanto a realização dos Testes Rápidos de ISTs nos serviços de saúde, de forma correta, e orientar sobre o processo de notificação				
Recursos necessários: → Computador; → Acesso à Internet; → Equipamento e material para higienização das mãos, conforme Manual de Biossegurança atualizado; → Luva de procedimento; → Algodão; → Kit diagnóstico fornecido pelo Ministério da Saúde; → Equipamento para descarte dos resíduos, conforme Manual de Biossegurança atualizado.				

CONCEITO

Os testes rápidos são uma importante estratégia de saúde pública na ampliação de diagnóstico, fornecendo aos serviços de saúde uma via mais acessível, rápida e de menor impacto na rede de atenção para diagnóstico do HIV, sífilis e hepatites B e C.

A execução, leitura e interpretação do resultado do teste rápido ocorrem em até 30 minutos por meio de amostra de sangue total obtida por punção digital, sem a necessidade de estrutura laboratorial.

Fatores que Interferem no resultado dos testes rápidos

O período de janela diagnóstica é caracterizado como o tempo decorrido entre o

contágio e o aparecimento de sintomas ou detecção de marcadores da infecção, seja ele antígeno ou anticorpo (no caso de anticorpo, também é chamado de janela imunológica).

A duração desse período é irregular, e varia dependendo do agente infeccioso, do marcador pesquisado, do tipo do teste, da sensibilidade do teste, do método utilizado para detectar o marcador e ainda das características da pessoa sendo testada, mas em regras gerais, é de aproximadamente 30 dias após a exposição.

Durante a janela diagnóstica, o teste pode apresentar resultado não reagente, mesmo se a pessoa estiver infectada, suspeitar fortemente do contágio ou apresentar sintomas de infecção de forma aguda.

A testagem para qualquer uma das ISTs pode sofrer interferência nos resultados em vigência de algumas patologias, gravidez ou em uso de terapia com anticorpos monoclonais e terapia antirretroviral. Estão descritas abaixo, as situações que podem gerar resultados falso negativos ou falso positivos nos testes:

- Vacina recente (menos de 30 dias);
- Artrite reumatóide;
- Colangite esclerosante primária;
- Terapia com interferon em pacientes hemodialisados;
- Síndrome de Stevens-Johnson;
- Anticorpo antimicrosomal ou antimonoclonal;
- Anticorpos HLA (classe I e II);
- Infecção viral aguda;
- Aquisição passiva de anticorpos anti-HIV (de mãe para filho);
- Tumores malignos;
- Outras retroviroses;
- Múltiplas transfusões de sangue;
- Anticorpo antimúsculo liso;
- Gravidez;
- Terapia antirretroviral.

Rastreabilidade do processo de testagem rápida

Conforme recomendado pela RDC ANVISA Nº 786, de 5 de maio de 2023, é necessário garantir a rastreabilidade de todo o processo de testagem rápida, com o intuito de garantir que não houve problemas técnicos relacionados ao lote, fabricante ou qualquer outra falha do kit diagnóstico, de modo que, se necessário e solicitado pelos órgãos competentes, seja possível identificar qual kit foi utilizado no diagnóstico de um usuário específico. Desta forma, o serviço deve registrar em documento físico e/ou

eletrônico (disponível em: [🏠 Controle de Teste Rápido](#) , para utilização pela unidade, gere uma cópia do arquivo):

- Dados do recebimento dos kits, como: número de lote, condições de transporte, data de recebimento;
- Matrícula no Sistema Integrado de Gestão (Olostech) do usuário testado, data e hora da execução do teste, tipo do teste/kit utilizado, número do lote do kit (caixa do kit, embalagem externa secundária) data de validade do kit e a rubrica do profissional executor e que emitiu o laudo;
- Ainda, é importante que sejam registradas condições específicas do usuário testado (ex: gestante, condições de vacinação) que podem influenciar no resultado daquele teste.

Profissionais aptos a realizarem teste rápido

Os profissionais enfermeiros, farmacêuticos, médicos e odontólogos estão aptos a realizarem os testes rápidos para detecção de ISTs na Rede de Atenção à Saúde (RAS) e fornecer laudo assinado com o resultado do teste realizado, desde que devidamente capacitados, conforme orientações disponíveis no Processo SEI Nº 24.0.264616-5.

Os Auxiliares e Técnicos de Enfermagem poderão realizar os testes rápidos para detecção de HIV, Sífilis e Hepatites Virais, desde que:

1. Sejam devidamente capacitados para esse fim;
2. Estejam sob supervisão direta ou indireta de enfermeiro;
3. Realizem os testes com a presença de pelo menos um enfermeiro na unidade de saúde;
4. Atendam usuários que receberam aconselhamento pré-teste por enfermeiro;
5. Encaminhem prontamente para o enfermeiro, para aconselhamento pós-teste e encaminhamentos, os usuários com resultado reagente;
6. Encaminhem para o enfermeiro, para aconselhamento pós-teste e encaminhamentos, os usuários com resultado não reagente;
7. Todos os laudos (reagentes e não reagentes) sejam emitidos por ENFERMEIRO.

Em situações em que o exame for realizado pelo auxiliar ou técnico de enfermagem, salienta-se que, a emissão do laudo dos resultados (Reagente ou não), somente poderá ser emitida, validada e assinada pelo profissional enfermeiro, porém, obrigatoriamente, tanto o técnico/auxiliar de enfermagem quanto o enfermeiro

responsável pela emissão do laudo, deverão realizar os registros em prontuário da realização do teste e seu resultado. O auxiliar ou técnico de enfermagem deverá obrigatoriamente registrar na anotação de enfermagem o nome do profissional que validou o exame e assinou o laudo.

NOTA: É OBRIGATÓRIO a todo profissional ser devidamente treinado e capacitado previamente para realizar os testes rápidos para ISTs. Mais informações sobre cursos obrigatórios poderão ser encontradas no Processo SEI Nº 24.0.264616-5.

População Alvo

Os testes rápidos podem ser realizados em toda a população, de acordo com os protocolos do Ministério da Saúde.

Quadro 01. Recomendação de testagem por idade

IDADE	RECOMENDAÇÃO	TCLE
ATÉ 18 MESES	Não deve ser realizado o teste rápido de HIV e Sífilis nessa faixa etária , devido à probabilidade de detecção de anticorpos maternos. Neste caso deve ser solicitado testes sorológicos.	-
18 MESES ATÉ 12 ANOS	É facultado ao profissional a realização do teste rápido na faixa etária entre 18 meses e 07 anos , podendo ser solicitado o exame para coleta endovenosa do teste treponêmico em laboratório com agendamento prévio, através do prontuário eletrônico via Sistema Integrado de Gestão (SIG – Saúde Tech), com o Código de Procedimento: 99000126 – Teste Treponêmico para Sífilis, Detecção de Imunoensaio Automatizado.	Para menores de 12 anos, os TRs devem somente ser realizados na presença dos pais ou responsáveis legais e mediante autorização dos responsáveis e assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 01).
12 ANOS ATÉ 17 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS	Resultado positivo, o responsável deve ser acionado e sempre que o profissional avaliar que o usuário não possui condições de discernimento e suspeita de algum tipo violência como: sexual, vulnerabilidade social, abandono e/ou maus tratos.	Consentimento formal do usuário ou responsável legal, por meio da assinatura do termo de consentimento, sem obrigatoriedade da presença do responsável para a realização do teste.
MAIORES DE 18 ANOS	-	A emissão do TCLE é facultativa para a realização do teste de HIV (Anexo 02).

O profissional deve ter um olhar criterioso para a realização dos testes em adolescentes menores de 14 anos devido a legislação vigente (vide quadro abaixo),

sendo garantido o atendimento e testagem a menores desacompanhados e/ou a usuários sem identificação, conforme Circular SEI Nº 0014504984, orientando-se que não haverá emissão de laudo ou o registro do resultado em prontuário nestes casos. Cabendo ainda ao profissional que realizar o exame sem identificação a orientação ao usuários que para emissão do laudo comprobatório ele deve retornar a unidade munido do documento com foto para nova testagem e emissão de laudo assinado pelo profissional responsável.

A privacidade e confidencialidade durante todas as etapas do processo, pré-teste, testagem e pós teste, devem ser mantidas de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados e Códigos de Ética de cada categoria apta a realizá-los.

Quebra de sigilo:

- A quebra do sigilo deve ser considerada sempre que houver risco à vida ou outros riscos relevantes para o usuário, ou quando o usuário não possuir discernimento sobre a doença e, porventura, possa expor terceiros a contaminação, a exemplo de situações como abuso sexual, risco ou tentativa de suicídio, risco ou tentativa de aborto, dependência de drogas, gravidez e outros.
- Nestes casos, a quebra de sigilo deve ser informada ao usuário, independentemente de sua concordância, registrar em prontuário, e com notificação via boletim de ocorrência *on-line*, notificação via Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), notificação de violência sexual (mesmo em casos de suspeita), e comunicação ao conselho tutelar, quando tratar-se de crianças e adolescentes.

Vulnerabilidade menores de 14 anos:

- Crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos incompletos (13 anos, 11 meses e 29 dias), independente do seu consentimento ou não para a prática do ato, sua experiência anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.
- TODOS os casos de gravidez em menores de 14 anos, sexo consensual ou não, prática de outros atos libidinosos, e/ou suspeita de exposição com risco de contaminação, DEVEM ser considerados estupro de vulnerável, de acordo com o artigo 217-A e parágrafos do Código Penal.
- A notificação aos órgãos competentes é OBRIGATÓRIA em qualquer situação descrita acima, a despeito de ter havido sexo consentido, mesmo sem violência ou grave ameaça e mesmo que a vítima já possua uma prática sexual ativa.

Rastreamento

O rastreamento é a realização de testes diagnósticos em pessoas assintomáticas a fim de estabelecer o diagnóstico precoce, com o objetivo de reduzir a morbimortalidade do agravo rastreado, e deve ser registrado em prontuário, se o teste foi realizado com caráter de rastreio ou de acordo com protocolo de grupo específico.



Quadro 02. Rastreamento de IST com uso de Teste Reagente

Quem	HIV	Sífilis	Hepatite B e C
Adolescentes e jovens (<30 anos)	Anual		Ver frequência conforme outros subgrupos populacionais ou práticas sexuais
Gestantes	• Primeira consulta do pré-natal (idealmente, no 1º trimestre da gestação) • Início do 3º trimestre (28ª semana) • No momento do parto, independentemente de exames anteriores • Em caso de aborto/natimorto, testar para sífilis, independentemente de exames anteriores		• Hepatite B: na primeira consulta do pré-natal (idealmente, no 1º trimestre) • Hepatite C: de acordo com o histórico de exposição de risco para HCV
Gays	Semestral		
Homens que fazem sexo com outros homens (HSH)			
Trabalhadores(as) do sexo			
Travestis e Transexuais			
Pessoas que usam álcool e outras drogas			
Pessoas com diagnóstico de IST	• No momento do diagnóstico; e • 4 a 6 semanas após diagnóstico de IST		• No momento do diagnóstico
Pessoas com diagnóstico de hepatites virais	• No momento do diagnóstico	-	-
Pessoas com diagnóstico de tuberculose	• No momento do diagnóstico	-	-
Pessoas vivendo com HIV (PVHIV)	-	Semestral	Anual
Prática sexual anal receptiva (passiva) sem uso de preservativos	Semestral		
Pessoas privadas de liberdade	Anual	Semestral	
Violência sexual	• Atendimento inicial; • 4 a 6 semanas após exposição; e • 3 meses após exposição	• Atendimento inicial; e • 4 a 6 semanas após exposição	• Atendimento inicial; e • 3 e 6 meses após exposição
Pessoas em uso de PrEP	• Em cada visita ao serviço e para renovação da prescrição;	Trimestral	
Pessoas com indicação de PEP	• Atendimento inicial; • 4 a 6 semanas após exposição; e • 3 meses após exposição	• Atendimento inicial; e • 4 a 6 semanas após exposição	• Atendimento inicial; e • 6 meses após exposição

Fonte: Guia prático para a execução de Testes Rápidos (BRASIL, 2022)



DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

Orientações Pré-Teste

O **ENFERMEIRO** deve certificar-se de que o usuário não teve algum tipo de exposição com risco recentemente, e explicar o que é janela diagnóstica. Para casos em que houver exposição recente, o profissional deve orientar o retorno do usuário em 30 dias a partir da data da orientação profissional, porém não contra indica o exame caso o usuário queira realizá-lo no primeiro atendimento.

Nos casos em que a exposição for recente e houver sinais e sintomas que indiquem a infecção por ISTs, o TR deve ser realizado no dia do primeiro atendimento e o usuário deve repetir os exames em 30 dias a partir da data da orientação profissional.

Para a realização de todos os TR de ISTs, o profissional deve questionar e certificar-se que não há suspeita de gravidez. Quando a usuária, porventura não souber informar, o teste de gravidez deve ser realizado previamente a todos os testes de IST.

Nota:

- A apresentação do documento de identificação não deve ser um critério para a oferta da testagem rápida. Se o usuário demonstrar o desejo de realizá-los, o profissional deve proceder com a realização dos testes conforme rotina técnica, porém o resultado deve ser **EXCLUSIVAMENTE** verbal, sem emissão de laudo pelo profissional responsável, e sem registro do resultado no sistema.
- O profissional deve gerar um atendimento no sistema informatizado, e registrar em ocorrências de saúde a realização do teste sem apresentação do documento, e que o resultado foi informado verbalmente.
- O profissional deve, ainda, aplicar o Termo de Consentimento para realização de Testes Rápidos sem documento de identificação com foto (Anexo 03), e arquivar a via física na unidade onde realizou o teste.

Quadro 03. Orientações de testagem

TESTE RÁPIDO	ORIENTAÇÕES
HIV	• Caso a exposição tenha ocorrido em menos de 72h, orientar com relação a Profilaxia Pós Exposição (PEP) e encaminhar para o Serviço de Referência (Pronto Atendimento), para condutas; • A exposição recente, não contraindica a realização do exame, porém, o teste deve ser repetido em caso de resultado negativo em um intervalo menor de 30 dias, quando houver risco; • Podem ocorrer resultados falsos reagentes em mulheres grávidas.
SÍFILIS	• Questionar se o usuário já teve sífilis e se já realizou tratamento para essa infecção anteriormente. • Em caso afirmativo, pedir a comprovação de tratamento, e independente de tratamento anterior, deve ser realizado novo TR, pois o resultado positivo pode indicar nova infecção, e tanto para resultados positivos quanto negativos (nos casos de relato de doença prévia relatada), deve ser solicitado o VDRL, justificando o motivo da solicitação do exame no pedido, conforme orientação da Nota Técnica SEI 22.0.337102-6;



	• Esclarecer que o Teste Rápido para sífilis detecta anticorpos que podem ser de uma infecção atual ou de infecções anteriores e que se reagente será necessário realizar testes complementares (VDRL);
HEPATITE B	• Questionar se o usuário é vacinado para hepatite B. • Nos casos em que a vacinação ocorreu nos últimos 21 dias antes da testagem, podem ocorrer resultados falsos reagentes nos testes que detectam o antígeno de superfície do HBV (HBsAg), e o teste deve ser repetido em 30 dias; • Caso a pessoa nunca tenha sido vacinada, não lembre ou não tenha comprovação, deve ser ofertada a vacina ou informar qual é o serviço mais próximo para a vacinação.

Realização do Teste Rápido

O teste rápido deve ser realizado com o Kit específico para cada infecção, e para tanto, cabe ao profissional ler a bula de cada kit e atentar-se para as diferenças da realização prática de cada teste.

Ressalta-se que a atenção no momento da abertura e realização dos testes está diretamente ligada aos resultados, visto que, os lotes e fabricantes dos kits podem mudar sem aviso prévio, e, portanto, a técnica de realização pode ser diferente entre os fabricantes.

Importante

- ✓ Ler a bula de instrução contida no KIT do teste;
- ✓ Registrar em Planilha interna do serviço todos os testes utilizados e os números de lotes de cada teste, e matrícula do usuário (disponível em: [📄 Controle de Teste Rápido](#), para utilização pela unidade, gere uma cópia do arquivo);
- ✓ Identificar o dispositivo de teste com as letras iniciais do nome do usuário;
- ✓ Realizar a higienização das mãos;
- ✓ Calçar as luvas de procedimento;
- ✓ Selecionar um dedo para fazer a punção;
- ✓ Aquecer o dedo, se a extremidade estiver fria;
- ✓ Realizar a antisepsia com álcool 70% na ponta do dedo e aguardar secagem completa;
- ✓ Evitar pressionar ou massagear o dedo puncionado, pois o excesso de pressão ou restrição de fluxo pode ocasionar hemólise;
- ✓ Retirar a amostra de sangue utilizando o instrumento específico de cada KIT e volume indicado pelo fabricante de cada teste;
- ✓ Colocar algodão no local da punção e solicitar para o usuário segurar até interromper o sangramento;
- ✓ Colocar o sangue no reservatório do cassete, sem encostar a pipeta ou capilar no reservatório;
- ✓ Pingar o reagente no reservatório conforme bula de cada teste (o volume varia entre cada fabricante), anotar a hora no cassete e aguardar o tempo conforme bula;
- ✓ Interpretar o resultado após o término do tempo de leitura, conforme bula;



- ✓ Comunicar o usuário ou responsável quanto ao resultado, preencher e assinar o laudo, registrar em prontuário, e entregar cópia do laudo ao usuário;
- ✓ Orientar o usuário e encaminhar se necessário para o seguimento conforme fluxo do município (Quadro 05);
- ✓ Registrar no Cartão da Gestante (pré-natal), o resultado do exame e orientar a testagem para parceria sexual, se a mesma consentir;
- ✓ Registrar no Sistema Integrado de Gestão (Olostech), informando o lote do teste utilizado e validade, inserindo o Código de Procedimento correspondente ao teste (Quadro 04);
- ✓ Notificar o agravo se teste reagente conforme protocolo do Ministério da Saúde;
- ✓ Desprezar o material utilizado conforme o Manual de Biossegurança (SEI 23.0.177095-2).

Observações:

- Não congelar o kit;
- Proteger o kit da ação da umidade;
- Não expor ao sol;
- Conservar o kit na faixa de temperatura que está indicada na bula de cada fabricante, e realizar controle diário ao menos uma vez ao dia;
- Conferir o prazo de validade impresso na parte externa da caixa do kit, antes de realizar o teste;
- Seguir as orientações de coleta minuciosamente, pois o volume da amostra e quantidade do reagente podem variar entre marcas diferentes.

Registro do Procedimento

A testagem dos usuários não é privativa de nenhuma categoria profissional, porém cabe ressaltar que, a emissão de laudo é privativa dos profissionais de nível superior, contudo, o registro da realização dos testes, resultado e orientações fornecidas é obrigatória para qualquer categoria profissional que realizar o teste, e ainda, é obrigatório para o auxiliar e técnico de enfermagem o registro em anotação de enfermagem o nome do profissional que realizou a conferência dos resultados e emitiu o laudo da testagem, para todos os casos, reagentes ou não.

Abaixo, seguem os códigos para registro dos procedimentos a serem utilizados, quando couber, para cada categoria profissional, no sistema informatizado.

Quadro 04. Código de Procedimento Tabela SIGTAP para profissionais de nível superior.

Código	Procedimento
03.01.01.003-0	Consulta de Profissionais de Nível Superior na Atenção Primária (Exceto Médico)
03.01.01.006-4	Consulta Médica em Atenção Primária
02.14.01.007-4	Teste Rápido para Sífilis
02.14.01.005-8	Teste Rápido para Infecção pelo HIV, Detecção de
02.14.01.010-4	Teste Rápido para Infecção pelo HBV, Detecção de
02.14.01.009-0	Teste Rápido para Hepatite C, Detecção de

Gestantes ou Parcerias Sexuais usar os seguintes Códigos para TR de HIV e Sífilis	
02.14.01.004-0	Teste Rápido para HIV na Gestante ou Pai/Parceiro, Detecção de
02.14.01.008-2	Teste Rápido para Sífilis na Gestante ou Pai/Parceiro

Quadro 05. Código de Procedimento para profissionais de nível médio.

Código para coleta de Teste Rápido para Auxiliar e Técnico de Enfermagem	
99980422	Coleta de Teste Rápido por Técnico de Enfermagem (PM)

Orientações Pós-Teste

Em caso de resultado não reagente para IST, e permanecendo a suspeita de infecção, deve-se realizar novo teste em 30 dias a partir da orientação do profissional. O usuário deve ser orientado que, mesmo em janela imunológica, TR não reagente, e suspeita de infecção ou exposição com risco de infecção, pode haver transmissão do agente infeccioso.

Um resultado não reagente indica que o teste não detectou o antígeno e (ou) anticorpo na amostra testada. No entanto, não exclui definitivamente que o indivíduo esteja infectado. Orientar sobre as medidas de prevenção, a fim de evitar futuras exposições de risco, e esclarecer que realizar apenas a testagem não evitará a transmissão de IST em novas exposições.

Nos casos de testes reagentes, o usuário deverá sair da unidade de testagem com as solicitações de exames complementares e/ou com os encaminhamentos, quando couber, e sempre que possível, coletar os exames complementares no mesmo momento do teste rápido.

O usuário deve ser orientado quanto à necessidade de testagem dos parceiros sexuais, porém, o usuário tem o direito ao sigilo, caso opte por não compartilhar o resultado com o parceiro.

Quadro 06. Fluxo de testagem e encaminhamentos

RESULTADO	ORIENTAÇÕES	
PRIMEIRO TESTE HIV REAGENTE	Realizar um segundo teste rápido no mesmo momento, de fabricante diferente.	
	SEGUNDO TESTE REAGENTE	SEGUNDO TESTE NÃO REAGENTE
	Profissional de nível superior deverá realizar a notificação via Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan e encaminhar o usuário para a Unidade de Assistência Especializada (UAE), com encaminhamento preenchido de forma completa, no formato receituário disponibilizado no Sistema Integrado de Gestão SIG – Saúde Tech, com os cópia dos laudos dos testes reagentes assinados pelo profissional de nível superior responsável pelo laudo ou supervisão.	Nos casos em que os dois testes rápidos apresentam resultados discordantes, repete-se a testagem com os mesmos tipos kits de diagnóstico utilizados anteriormente (mesmo lote e fabricante), na mesma ordem realizada anteriormente.
	NOVOS TESTES CONCORDANTES	NOVOS TESTES DISCORDANTES
	Profissional de nível superior deverá realizar a notificação via Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan e encaminhar o usuário para a Unidade de Assistência Especializada (UAE), com encaminhamento preenchido de forma completa, no formato receituário disponibilizado no Sistema Integrado de Gestão SIG-Saúde Tech, com cópia dos laudos dos testes reagentes assinados pelo profissional de nível superior responsável pelo laudo ou supervisão.	O enfermeiro deverá solicitar sorologia no SIG-SaudeTech e encaminhar o usuário para coleta no laboratório municipal, conforme agendamento com laboratório, sem fornecer laudo do resultado do teste rápido , e orientando o usuário a coletar o exame sorológico e aguardar o resultado para confirmação.
HEPATITES VIRAIS REAGENTES	Notificar na Plataforma Sinan e encaminhar o usuário para o Programa de Hepatites Virais do Município, na Unidade de Assistência Especializada (UAE) com encaminhamento preenchido de forma completa, no formato receituário disponibilizado no Sistema Integrado de Gestão SIG – Saúde Tech, com o resultado do teste rápido em anexo e o laudo do mesmo assinado pelo profissional responsável pela realização do teste.	
SÍFILIS REAGENTE	- O resultado reagente indica que o usuário foi exposto ao agente causador da sífilis pelo menos uma vez na vida, mas não necessariamente que esteja com sífilis no momento da realização do teste. - Deve-se informar que se trata de um teste inicial e que é necessária a realização de testes complementares para definir o diagnóstico, conforme “Orientações para solicitação de exames laboratoriais para Sífilis”, SEI 22.0.337102-6, e ainda seguindo as orientações para os códigos específicos para cada exame, conforme SEI 0024791474. - No âmbito da Secretaria da Saúde de Joinville, Médicos e Enfermeiros podem solicitar o VDRL para confirmação diagnóstica, e em todos os casos em que o teste rápido for reagente, a coleta de VDRL deve ser realizada, seja para diagnóstico ou monitoramento; - Para gestantes, parceria sexual da gestante e crianças, caso não tenha vaga nos próximos dias no laboratório para a coleta de VDRL, deve-se agendar o exame para data mais próxima e encaminhar e-mail para: olos.laboratorios@gmail.com, com o número do pedido do exame gerado via Sistema Integrado de Gestão SIG – Saúde Tech, justificando o motivo da urgência.	

Nota: O profissional de nível superior que realizar o exame ou supervisionar a realização deve, **OBRIGATORIAMENTE**, preencher e **EMITIR** o laudo **FÍSICO** do resultado e as informações em prontuário eletrônico com resultado **“Reagente”** ou



“Não Reagente”, evitando o uso da palavra “Positivo” ou “Negativo”, SEMPRE que os testes forem realizados em usuários com identificação;

Cabe às Unidades Básicas de Saúde monitorar se o usuário compareceu no Serviço Especializado para avaliação e condutas, e realizar busca ativa se necessário.

Contato da Unidade de Assistência Especializada:

- Serviço de Atendimento Especializado (SAE): 07h00 às 19h00 - (47) 3417-1394
- Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA): 07h00 às 18h30 - (47) 3417-1377
- Hepatites virais, hanseníase e tuberculose: 07h00 às 13h00 - (47) 3417-1398



REFERÊNCIAS

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COFEN). **Parecer de Conselheiro Federal nº 259/2016/COFEN**. Discute sobre a competência para a realização de Testes Rápidos e emissão de Laudos. Rio de Janeiro – RJ: 2016;

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis, do HIV/AIDS e das Hepatites Virais. Universidade Federal de Santa Catarina. **Infecções Sexualmente Transmissíveis: Cuidados na Execução dos Testes Rápidos. Módulo 2: Orientações Pré e Pós Testes**. Florianópolis – SC: 2017;

BRASIL. Ministério da Saúde. **Cuidando De Adolescentes: Orientações Básicas para a Saúde Sexual e a Saúde Reprodutiva**. Brasília – SC: 2018;

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das IST, do HIV/Aids e das Hepatites Virais. **Diagnóstico de Hepatites Virais – Telelab**. Programa de educação continuada do Ministério da Saúde. Brasília – SC: 2018. Disponível em: <https://telelab.aids.gov.br/index.php/component/k2/item/94-diagnostico-de-hepatites-virais>;

BRASIL. Ministério da Saúde. **Instrução Normativa Nº 593, De 20 De Maio De 2015**. Brasília – DF: 2015;

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. **Guia prático para a execução de testes rápidos: DIAG/DCCI/SVS/MS**. Brasília – DF: 2022;

PREFEITURA DE JOINVILLE. Secretaria da Saúde de Joinville. **SEI 22.0.337102-6: Orientações para solicitação de exames laboratoriais para Sífilis**. Joinville – SC: 2022;

PREFEITURA DE JOINVILLE. Secretaria da Saúde de Joinville. Gerência de Gestão Estratégica. Coordenação de Enfermagem. SEI 23.0.177095-2. **Manual de Biossegurança**. Joinville – SC: 2023.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por:
2015 Comissão de Enfermeiros da Atenção Básica.	2025 NGQP Manuelle Hölscher Belz; Willian Waldelino Custodio da Silva.	2025 Gerência da Qualidade e Desenvolvimento Institucional Juliana Antunes Safanelli.

Disponível pelo Endereço Eletrônico
Sistema Eletrônico de Informação (SEI): Processo nº 20.0.183593-5
Wiki da Prefeitura: https://wiki.joinville.sc.gov.br/index.php/Área:_Saúde

ANEXOS

Anexo 01. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido / Realização de Testes Rápidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis em Crianças e Adolescentes.

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)
REALIZAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS DE INFECÇÕES SEXUALMENTE
TRANSMISSÍVEIS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Eu, _____, nascido(a) em ____/____/____, portador(a) do documento (RG/CPF) _____, representante legal do(a) menor _____, nascido(a) em ____/____/____, portador(a) do documento (RG/CPF) _____, autorizo a coleta de material biológico para a realização dos testes rápidos de HIV, Sífilis, Hepatite B e C e demais testes complementares que se fizerem necessários.

Declaro estar ciente de que, caso haja necessidade, poderá ser solicitada nova coleta de sangue para esclarecimento diagnóstico, conforme Portaria Ministerial nº 29, de 17 de dezembro de 2013.

Declaro ter compreendido e concordado com todos os termos deste Consentimento Informado.

Local: _____

Data: ____/____/____

Assinatura do(a) Responsável



Anexo 02. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido / Realização de Teste Rápido Vírus Da Imunodeficiência Humana (HIV) em Adultos.

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)
REALIZAÇÃO DE TESTE RÁPIDO VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA (HIV) EM ADULTOS

Eu, _____, nascido(a) em ____/____/____, Portador(a) do documento (RG/CPF) _____, autorizo a coleta de material biológico para a realização do teste rápido do vírus da imunodeficiência humana (HIV).

Declaro estar ciente de que, caso haja necessidade, poderá ser solicitada nova coleta de sangue para esclarecimento diagnóstico.

Declaro ter compreendido e concordado com todos os termos deste Consentimento Informado.

Local: _____

Data: ____/____/____

Assinatura do(a) Usuário(a)



Anexo 03. Termo de Consentimento / Realização de Testes Rápidos Sem Documento de Identificação Com Foto.

TERMO DE CONSENTIMENTO
REALIZAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS SEM DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO

Eu, _____,
data de nascimento ____/____/____, RG _____, Órgão Emissor
_____, CPF _____, Cartão Nacional do SUS
_____, venho por meio deste TERMO, solicitar a realização
de Teste Rápido sem a apresentação de documento de identificação oficial com foto.

Informo que fui orientado(a) que o resultado de teste rápido de gravidez e/ou IST sem a apresentação do documento de identificação oficial será informado verbalmente, registrado em prontuário eletrônico e que o laudo físico (impresso) será fornecido tão logo eu apresente documento de identificação oficial.

Assim, **DECLARO** que estou ciente da importância da apresentação de documento de identificação oficial com foto para realização de procedimentos em Serviços de Saúde.

Local: _____

Data: ____/____/____

Assinatura do(a) Usuário(a)